Att berätta om cancer

En studie om hur narrativ, retorik och visuell kommunikation kan användas för att förklara cancer för barn i åldern 6–9 år

Tina Håkansson

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen visualisering och textdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator Anna-Lena Carlsson
Handledare Thomas Petersson
Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet
2026-06-27

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker hur information om cancer kan gestaltas för barn i åldern 6–9 år på ett sätt som gör den begriplig och trygghetsskapande. Arbetet utgår från att många föräldrar upplever det som svårt att kommunicera om allvarlig sjukdom med sina barn, samtidigt som det finns ett begränsat utbud av informationsmaterial som fungerar både för barnet och som stöd för vuxna i samtal.

Som teoretisk grund används narrativ teori, retorik, semiotik och visuell kommunikation. Metoderna som använts är litteraturstudier, omvärldsanalys av barnböcker och informationsmaterial samt semistrukturerade intervjuer med föräldrar och en barnboksförfattare. Gestaltningen har även utprovats med tre deltagare.

Resultatet visar att kombinationen av narrativ struktur, ikoniska illustrationer och faktabaserad information kan bidra till att skapa ett material som upplevs som begripligt och trygghetsskapande. Genom att presentera information ur barnets perspektiv, med ett enkelt och konkret språk samt ett lugnt visuellt uttryck, skapas förutsättningar för att barnet ska kunna ta till sig svår information utan att känna onödig oro. Utprovningarna indikerade även att materialet upplevdes som tydligt och användbart som stöd i samtal mellan vuxna och barn.

Slutsatsen är att information om cancer kan göras mer tillgänglig för barn genom berättelser ur barnets perspektiv, igenkännbara illustrationer och faktabaserade förklaringar. Dessa element bidrar till att konkretisera informationen och göra den lättare för barn att förstå.

Nyckelord: Barn och cancer, informationsdesign, narrativ, visuell kommunikation, samtalsstöd.

Abstract

This thesis examines how information about cancer can be designed for children aged 6–9 in a way that makes it understandable and reassuring. The study is based on the observation that many parents find it difficult to communicate about serious illness with their children, while there is a limited range of informational materials that function both for the child and as support for adults in conversation.

The theoretical framework consists of narrative theory, rhetoric, semiotics, and visual communication. The methods used include literature studies, an environmental scan of children's books and informational materials, as well as semi-structured interviews with parents and a children's book author. The design concept was also tested with three participants.

The results show that a combination of narrative structure, iconic illustrations, and fact-based information can contribute to creating material that is perceived as understandable and reassuring. By presenting information from the child's perspective, using simple and concrete language and a calm visual expression, conditions are created for the child to process difficult information without experiencing unnecessary anxiety. The user tests also indicated that the material was perceived as clear and useful as support in conversations between adults and children.

The conclusion is that information about cancer can be made more accessible to children through stories told from the child's perspective, relatable illustrations, and fact-based explanations. These elements help to make the information more concrete and easier for children to understand.

Keywords: Children and cancer, information design, narrative, visual communication, conversational support.

Innehåll

Sammanfattning ..... **I**

Abstract ..... **II**

1 Inledning **1**

1.1 Bakgrund *1*

1.2 Målgrupp *1*

1.3 Problemformulering *2*

1.4 Syfte och frågeställning *2*

1.5 Avgränsningar *3*

2 Tidigare forskning **4**

3 Teori **5**

3.1 Narrativ *5*

3.2 Retorik *5*

3.3 Semiotik *6*

3.4 Visuell kommunikation *7*

4 Metod **8**

4.1 Litteraturstudier *8*

4.2 Omvärldsanalys *8*

4.2.1 Urval 8

4.3 Semistrukturerad intervju *9*

4.3.1 Urval 9

4.3.2 Analys av kvalitativa data 10

4.4 Utprovning *10*

4.5 Metodkritik *10*

5 Förstudie **11**

5.1 Insamling av data *11*

5.2 Analys av data *12*

5.2.1 Omvärldsanalys 12

5.2.2 Intervjuer 14

5.2.3 Sammanfattning 15

5.3 Resultat *16*

6 Designprocess **18**

6.1 Skisser *19*

6.2 Designval *22*

6.2.1 Format 22
6.2.2 Informationsurval 22
6.2.3 Att skriva för barn 22
6.2.4 Typografi 23
6.2.5 Narrativ 23
6.2.6 Retorik 24
6.2.7 Semiotik 24
6.2.8 Visuell kommunikation 24

6.3 Utprovning 25
6.3.1 Utprovning 1 25
6.3.2 Utprovning 2 26
6.3.3 Utprovning 3 26
6.3.4 Sammanfattning 27

7 Gestaltningsförslag 28

8 Diskussion och slutsats 30

8.1 Diskussion 30

8.2 Slutsats 33

9 Källförteckning 34

9.1 Tryckta källor 34

9.2 Elektroniska källor 35

9.3 Otryckta källor 38

9.4 Bildförteckning 38

10 Bilagor 39

10.1 Analysmall 39

10.2 Samtyckesformulär 40

10.3 Intervjuguide 41

10.4 Intervjuguide författarintervju 42

10.5 Frågeguide utprovning 43

10.6 Slutgiltigt gestaltningsförslag 44

1 Inledning

Detta examensarbete behandlar hur information om cancer kan utformas för barn i åldern 6–9 år. När en förälder eller närstående drabbas av cancer påverkas hela familjen, och barn kan ha ett stort behov av stöd och information. Samtidigt kan det vara svårt för de vuxna att veta hur man ska förklara på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och förståelse.

1.1 Bakgrund

Barn påverkas i hög grad när en närstående blir sjuk i cancer. I en sådan situation uppstår ofta många frågor, och barnet behöver få svar på sina frågor för att känna trygghet och förstå vad som händer. Om barn inte får information finns enligt 1177 (2026) en risk att de själva försöker fylla i luckor, vilket kan leda till oro och missförstånd.

Samtidigt är det en utmaning för vuxna att prata med barn om allvarlig sjukdom. Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sig eller att avgöra hur mycket information barnet behöver (Kenny et al., 2021). Barns förståelse varierar beroende på ålder och mognad, vilket ställer krav på att informationen är anpassad både språkligt och innehållsmässigt. Forskning visar även att många vuxna upplever osäkerhet kring hur mycket information man kan ge utan att orsaka onödig oro eller rädsla hos barnet (Xu et al., 2024).

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) säger att ett barns behov av information särskilt ska beaktas bland annat om en förälder eller annan vuxen som barnet bor med har en allvarlig sjukdom. Åtgärder som är riktade till barnet kan enligt forskning bidra till ökat psykiskt välbefinnande hos barn som har en sjuk förälder. Genom att ge barnet möjlighet att förstå situationen och sätta ord på sina känslor kan sådana insatser fungera som ett viktigt stöd (Zhao et al., 2024). En effektiv kommunikation kan hjälpa barnet att förbereda sig på det som kommer hända, och brist på information kan i stället bidra till att barnet inte litar på varken sina föräldrar eller sjukvården. Forskning visar att det finns ett behov av informationsmaterial som riktar sig till barn och familjer (Yamaji et al., 2022).

1.2 Målgrupp

Materialet som gestaltas i arbetet riktar sig primärt till barn i åldern 6–9 år, men är även utformat för att fungera som stöd för vuxna i samtal med barn om cancer. Målgruppen omfattar därmed läsare med olika behov och förutsättningar, vilket ställer särskilda krav på hur materialet utformas.

Enligt Piagets teori om kognitiv utveckling, beskriver Crain (2010, s. 127) att barn i åldern 6–9 år befinner sig i en övergångsfas mellan två utvecklingsstadier. Yngre barn, runt sex års ålder, befinner sig fortfarande i det

preoperationella stadiet där tänkandet kan beskrivas som egocentriskt. Det innebär inte att barnet är själviskt, utan snarare att barnet uppfattar världen utifrån sin egen synvinkel och har svårt att ta in flera perspektiv samtidigt (Crain, 2010, s. 133). Vid ungefär sju års ålder påbörjas övergången till det konkret operationella stadiet, där förmågan att tänka logiskt kring konkreta händelser successivt utvecklas (Crain, 2010, s. 127). Detta bekräftas även av 1177 (2026) som beskriver att barn från ca sex års ålder börjar intressera sig mer för hur verkligheten ser ut och vill ha mer konkreta förklaringar kring vad som händer. Ett barn på sex år och ett barn på nio år kan alltså ha betydligt olika förutsättningar för att ta till sig och bearbeta information om sjukdom, vilket ställer krav på att materialet är konkret, visuellt tydligt och språkligt tillgängligt även för de yngre barnen i spannet.

Målgruppen befinner sig i en övergång mellan högläsning och självständig läsning. Materialet behöver därför fungera både för barnet som läser själv och i en situation där en vuxen läser högt tillsammans med barnet. Bateman (2014, s.88) beskriver hur bilderboken som format möjliggör just detta genom sin dubbla orientering. Det innebär att text och bild kan läsas var för sig men tillsammans skapar en rikare berättelse, vilket gör att barn och vuxna kan ta del av samma material på olika nivåer utan att någon av upplevelserna blir ofullständig.

Den vuxne utgör en sekundär målgrupp. Många vuxna upplever det som svårt att formulera information om allvarlig sjukdom på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och förståelse (Kenny et al., 2021). Materialet är därför utformat för att även kunna fungera som ett stöd att luta sig mot i samtalet, särskilt i situationer där den som är sjuk själv ska berätta om sjukdomen för barnet. Det kan vara svårt att hantera sina egna känslor och samtidigt hitta rätt ord och formuleringar.

1.3 Problemformulering

Trots att barn påverkas när en närstående drabbas av cancer saknas informationsmaterial som är utformat för att fungera både för barnet och som stöd för vuxna i samtal om sjukdomen. Detta väcker en fråga om hur text och bild kan utformas för att möta båda behoven samtidigt.

1.4 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka hur text och bild kan utformas för att göra information om cancer begriplig och trygghetsskapande för barn i åldern 6–9 år, med särskilt fokus på narrativa och retoriska strategier. Studien syftar även till att utveckla ett informationsmaterial anpassat för målgruppen, som kan fungera som stöd i samtal mellan barn och vuxna.

Frågeställningen är:

Hur kan text och bild, genom narrativa och retoriska strategier, utformas för att förklara cancer för barn i åldern 6–9 år på ett begripligt och trygghetsskapande sätt?

Till hjälp för att svara på frågeställningen har även två underfrågor formulerats:

- Vilka visuella, narrativa och retoriska strategier kan användas för att göra information begriplig för barn?
- Hur kan ett informationsmaterial utformas visuellt och innehållsmässigt för att fungera både för barnet enskilt och som stöd i samtal med vuxna?

1.5 Avgränsningar

Detta arbete har avgränsats till att behandla bröstcancer och inte cancer generellt. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (1177, 2025), och en avgränsning möjliggör ett mer konkret informationsmaterial. Materialet riktar sig till barn som har en förälder eller närstående som är sjuk, och inte till barn som själva har drabbats av cancer. Datainsamling samt utprovning av materialet ämnar genomföras med vuxna deltagare och inte med barn i målgruppen, av etiska skäl och med hänsyn till ämnets känslighet.

2 Tidigare forskning

Tidigare forskning visar att många föräldrar upplever att det är en komplex utmaning att kommunicera om cancer till sina barn (Alfieri et al., 2026; Xu et al., 2024). Flera studier beskriver att föräldrar ofta vill vara öppna i sin kommunikation, men samtidigt känner osäkerhet kring hur, när och hur mycket information som bör delas med barnet. Denna osäkerhet påverkas bland annat av att man har svårt att veta vilket informationsbehov barnet har, vilket kan göra att kommunikationen blir svår att genomföra i praktiken (Kenny et al., 2021).

Forskning visar även att det finns ett behov av informationsmaterial som är anpassat till familjer, och framför allt till barn. Brist på information kan göra att barnet känner mindre tillit till sina föräldrar och andra vuxna, medan en effektiv kommunikation kring sjukdomen kan bidra till att barnet känner sig mer förberedd på det som sker och därför känner sig tryggare (Yamaji et al. 2022). Forskning tyder även på att material som är riktat till familjer är att föredra då de inte bara kommer till användning för antingen förälder eller barn, utan bidrar till en mer öppen och positiv kommunikation kring sjukdomen i hela familjen. Material som är riktade till barn anses bidra till barnets välmående då det hjälper barnet att förstå förälderns situation (Zhao et al, 2024).

Storytelling har visat sig vara mer effektiv än andra mer traditionella insatser för att minska stress hos barn som är inlagda på sjukhus. Man menar att barnen genom berättelser lär sig att bearbeta sina känslor på ett sätt som är både relaterbart och intressant (Ku et al., 2025). Det är dock viktigt att tänka på att alla barn har olika förståelse och att informationen behöver vara anpassad efter ålder och mognadsnivå för att den ska fungera lugnande.

Forskning visar att serier kan vara ett relevant format för information om hälsa och sjukdom. Text och bild i kombination blir mycket relevant, och bildfokuset gör det möjligt att ge information även till de som inte läser så bra eller har begränsad kunskap om ämnet. Detta är användbart för kommunikation om känsliga ämnen (Rakower & Hallyburton, 2022). Detta gäller inte bara för specifikt serieformatet, utan kan även appliceras på text och bild i kombination, då det är kombinationen som underlättar läsning och förståelse. Formatet väcker även uppmärksamhet genom att berätta om relevanta karaktärer och situationer, likt det Ku et al (2025) nämner om storytelling.

Tidigare forskning har även använt innehållsanalys av bilderböcker för att undersöka hur svåra ämnen kommuniceras till barn. Sarı Uğurlu & Apaydın (2023) analyserade turkiska bilderböcker om klimatförändringar med fokus på narrativa och innehållsliga aspekter. Denna studie har inspirerat den analysmetod som använts i omvärldsanalysen i detta arbete.

3 Teori

I detta avsnitt kommer teorier som är relevanta för arbetet beskrivas. Teorier om narrativ, retorik, semiotik och visuell kommunikation kommer ligga till grund för att ta fram ett gestaltningsförslag.

3.1 Narrativ

Ett narrativ är enligt Abbott (2021, s.12) en representation av en serie händelser. Han menar att man utan händelser enbart har en beskrivning eller ett argument, men inte ett narrativ. Det handlar om hur händelser ordnas och kopplas samman till en meningsfull helhet. Genom att organisera information i en berättelse kan samband mellan händelser bli tydligare för mottagaren. Narrativ skapar därmed inte bara en kronologisk ordning, utan också en förståelse för hur och varför något sker.

Abbott (2021, s.46) menar att narrativets retoriska funktion kan förstås som att alla delar av en berättelse bidrar till att skapa mening och upplevelse för läsaren. Även små förändringar i berättelsens struktur eller innehåll påverkar helheten, vilket innebär att narrativ inte enbart förmedlar innehåll utan även formar hur innehållet upplevs.

Narrativ är särskilt effektivt som kommunikationsform för barn. Ku et al. (2025) menar att storytelling hjälper barn att identifiera och bearbeta känslor på ett sätt som är både begripligt och minnesvärt. Genom berättelsen kan svår information göras mer relaterbar än rena fakta, vilket är särskilt relevant när ämnet är känslomässigt svårt att ta in.

I detta arbete används narrativ för att strukturera informationsmaterialet. Genom att rama in fakta med en berättelse om en igenkännbar situation skapas förutsättningar för att barnet ska kunna ta till sig och bearbeta information om cancer på ett tryggt och begripligt sätt.

3.2 Retorik

Retorik handlar om hur budskap kan utformas för att skapa förståelse och nå fram till en mottagare. Inom retoriken talar man ofta om de tre övertygelsemedlen ethos, pathos och logos för att beskriva olika sätt att övertyga en publik (Lindqvist, 2016, s. 74).

Ethos använder man enligt Lindqvist (2016, s.83) för att framstå som en pålitlig avsändare gentemot sin publik. Det kan handla om den karaktär man visar upp för publiken, men trovärdighet kan även etableras genom att exempelvis använda pålitliga källor till sina påståenden och presentera information på ett genomtänkt sätt. Pathos handlar om att väcka mottagarens känslor. Lindqvist (2016, s.82) menar att vi behöver förstå vad mottagaren känner för att kunna påverka denne. Logos bygger på logik och argument, och handlar enligt

Lindqvist (2016, s.82) om att ge bevis för våra påståenden för att övertyga mottagaren. Genom att kombinera dessa strategier kan man öka möjligheterna att nå fram med sitt budskap.

I information som riktar sig till barn är alla tre övertygelsemedlen relevanta. Materialet behöver kännas tryggt och pålitligt, ta hänsyn till barnets känslor och förmedla information på ett konkret och begripligt sätt. I detta arbete används ethos, pathos och logos som utgångspunkt för att utforma hur materialets text och bild tillsammans kommunicerar med mottagaren.

3.3 Semiotik

Semiotik är studien av tecken och hur dessa skapar mening. Ett tecken definieras inom semiotiken som något som står för eller representerar något annat (Chandler, 2022, s.2). Tecken kommer i många olika former, och kan vara allt från bilder till ord eller gester. Semiotiken syftar till att förstå hur människor tolkar dessa tecken och symboler som vi omges av, och Chandler (2022, s.2) menar att kommunikation, kultur och förståelse påverkas av dessa tecken och hur vi har lärt oss att tolka dem.

Inom semiotiken pratar man ofta om Peirces tre teckentyper: ikon, symbol och index. De beskriver inte tre olika sorters tecken, utan snarare tre olika sätt som ett tecken kan tolkas i förhållande till vad det avbildar (Chandler, 2022, s.42).

Ett ikoniskt tecken bygger på likhet mellan tecknet och det som avbildas, vilket gör att det blir lätt att känna igen (Chandler, 2022, s.43). Ett symboliskt tecken har inte en lika naturlig koppling till vad det symboliserar, utan bygger i stället på konventioner man måste lära sig för att förstå. Alla typer av ord är ett tydligt exempel på detta, men även trafikskyltar och flaggor är något vi har lärt oss att tyda (Chandler, 2022, s.42). Index är i stället baserat på samband. Exempelvis är fotspår i snön ett index för att någon har passerat, utan att personen själv behöver vara synlig (Chandler, 2022, 43). Peirces teckenkategorier används i det här arbetet för att undersöka hur illustrationer och visuella element förhåller sig till det de avbildar, och hur olika typer av tecken samverkar för att skapa förståelse hos mottagaren.

Ytterligare två centrala begrepp inom semiotiken är denotation och konnotation. Begreppen förknippas ofta med Roland Barthes som använde dem för att analysera hur bilder kommunicerar på flera nivåer samtidigt. Denotationen är bildens bokstavliga innehåll, alltså det som faktiskt är avbildat. Konnotationen är de associationer, känslor och kulturellt inlärda värderingar som bilden väcker utöver detta (Ledin & Machin, 2018, s.48). I detta arbete används begreppen för att analysera hur materialets illustrationer kommunicerar på båda nivåerna samtidigt, både vad de bokstavligt avbildar och vilka känslor och associationer de är avsedda att väcka hos mottagaren.

3.4 Visuell kommunikation

Eriksson (2017, s. 81) beskriver visuell kommunikation utifrån en kommunikationsmodell bestående av en sändare, ett meddelande och en mottagare. Både sändare och mottagare har olika tidigare erfarenheter, vilket påverkar hur ett budskap kommer utformas respektive tolkas. Om sändare och mottagare inte delar samma kontext kan tolkningsproblem uppstå, så det är inte säkert att budskapet kommer tolkas som det är tänkt (Eriksson, 2017, s. 82). Eriksson (2017, s. 84) beskriver vidare att bilder har både en yttre och en inre kontext, och att bilder bör förses med läsanvisningar som hjälper mottagaren att tolka bilden på det tänkta sättet.

Bilder kan tolkas på många olika sätt beroende på betraktare och sammanhang. Kress & Van Leeuwen (2006, s.18) beskriver hur Roland Barthes skiljde mellan två olika sätt som text och bild kan förhålla sig till varandra, ankare och relä. Ankare innebär att texten förankrar bilden och därmed styr hur den tolkas. Det kan till exempel vara när en bildtext förklarar vad som visas i en bild. Ett reläförhållande innebär i stället att text och bild kompletterar varandra och var för sig bidrar med ny information som tillsammans skapar en betydelse som ingen av dem kan förmedla på egen hand.

I detta arbete används dessa begrepp för att undersöka hur text och bild samverkar i materialet, samt hur de kan utformas för att stödja barnets förståelse.

4 Metod

Detta avsnitt behandlar de metoder som har använts under arbetets olika delar.

4.1 Litteraturstudier

För att identifiera relevant forskning genomfördes systematiska sökningar i databaserna Scopus och Primo. Sökningarna syftade till att hitta forskning om kommunikation kring cancer och allvarlig sjukdom med barn, barns informationsbehov samt användning av storytelling och narrativ som kommunikationsverktyg för barn. Sökningen avgränsades till artiklar publicerade från 2020 och framåt för att säkerställa att forskningen är aktuell. Sökningarna genomfördes med sökord och kombinationer som "*parents communicating illness to children"*, "*storytelling + anxiety + children"*, "*health education + disease information + graphic"* och "*communication + cancer + children"*. Utöver databassökningarna användes även snöbollsmetoden, där referenslistor i relevanta artiklar granskades för att identifiera ytterligare källor.

4.2 Omvärldsanalys

Enligt Furustig och Sjöstedt (2000, s. 7–8) används omvärldsanalys för att undersöka delar av den yttre omgivningen och skapa ett underlag för beslut och planering. Metoden kan även bidra till ökad förståelse för hur ett område ser ut.

I det här arbetet används omvärldsanalysen för att skapa en överblick över hur information om svåra och komplexa ämnen utformas för barn i praktiken.

Som en del av omvärldsanalysen ingick en genomgång av information riktad till barn som tagits fram av olika organisationer och myndigheter. Fokus låg på material som är anpassat för yngre barn, exempelvis från Lilla krisinfo (2025), Rädda barnen (u.å.), Mina rättigheter (u.å.), och Jag vill veta (u.å.). Även andra organisationer som riktar sig till barn och unga studerades översiktligt, men flera av dessa var anpassade för en äldre målgrupp och var därför inte lika relevanta för den här studien.

I omvärldsanalysen gjordes även en genomgång av tio barnböcker som handlar om cancer. Inspirerat av en studie av innehåll i bilderböcker om klimatförändringar (Sarı Uğurlu & Apaydın, 2023), har analysen fokuserat på narrativa och innehållsliga aspekter såsom karaktärer, berättelsestruktur, språk, illustrationer samt vetenskaplig och faktamässig information.

4.2.1 Urval

Urvalet baseras på tre olika listor med boktips framtagna av Region Jönköpings län (2025), Sjukhusbiblioteken i Värmland (2020) samt Anhörigas riksförbund (2021). Listorna innehåller rekommenderade böcker för barn och berör ämnen

som allvarlig sjukdom, barn som anhöriga samt andra svåra ämnen. Av de tio böcker som ingår i analysen rekommenderades åtta titlar av Region Jönköping, fyra av Region Värmland och tre av Anhörigas riksförbund. Två av böckerna återfinns i samtliga tre listor, vilket indikerar en hög relevans för denna studie. Urvalet avgränsades vidare till titlar som vid tillfället fanns tillgängliga på Täby bibliotek och Eskilstuna stadsbibliotek. Samtliga böcker är utgivna på svenska och riktar sig till barn i åldern cirka 6–9 år.

Böckerna som har analyserats är:

Du är modigast av Christina Wahldén & Bettina Johansson
En dum knöl i mammas bröst av Annie Hagvall Einarsrud och Hanna Ingvarsson
Fakta om cancer av Eva Susso
Mammas liv av Mi Tyler & Malin Ahlin
Mamma ska bli en enhörning av Annie Hagvall Einarsrud & Hanna Ingvarsson
Min skalliga mamma av Camilla Dahlson & Katarina Vintrafors
Mitt fönster mot rymden av Oskar Kroon & Josefin Sundqvist
När mormor fick cancer av Minna Paananen & Elisabeth Widmark
När pappa blev Skalle-Per av Anna-Karin Elwin Segolsson & Karin Lundqvist
Oliver och cancer av Maria Aminoff & Cissi Welin

4.3 Semistrukturerad intervju

Intervjuer är lämpliga när man undersöker komplexa frågor som kräver att man får en djupare förståelse för ämnet. Genom att ta del av erfarenheter och perspektiv från personer med relevant kunskap kan intervjuer bidra med värdefulla insikter (Denscombe, 2018, s.268).

Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en lista med förbestämda frågor man vill ha besvarade, men samtidigt finns det utrymme att vara flexibel för att anpassa intervjun efter deltagarnas svar (Wikberg Nilsson et al, 2021, s.89).

4.3.1 Urval

Bekvämlighetsurval innebär att man väljer deltagare som finns nära till hands (Denscombe, 2018, s.71). Snöbollsurval innebär att befintliga deltagare rekommenderar nya deltagare (Denscombe, 2018, s.70), medan ett subjektivt urval innebär att deltagare väljs utifrån specifika egenskaper eller kunskaper som är relevanta för studien (Denscombe, 2018, s.67).

Intervjuer genomfördes dels med föräldrar till barn i målgruppen samt med en författare som har skrivit en barnbok om cancer. Intervjuerna med föräldrar inleddes med ett bekvämlighetsurval, där en person med barn i rätt ålder kontaktades. Personen rekommenderade därefter ytterligare två personer som också kontaktades. Föräldrarna valdes eftersom de har en central roll i att förmedla information till barn i situationer när en närstående är sjuk, och därför kan de bidra med värdefulla insikter. Författaren valdes baserat på sin erfarenhet av att kommunicera ett komplext och känsligt ämne till en yngre målgrupp samt egen erfarenhet av cancer.

4.3.2 Analys av kvalitativa data

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas. Det transkriberade materialet utgjorde sedan grunden för analysen som genomfördes inspirerat av en kvalitativ analysprocess som beskrivs av Denscombe (2018, s.344) Analysprocessen inleddes med att materialet lästes igenom upprepade gånger för att identifiera återkommande mönster. Relevanta uttalanden kodades genom att markeras och antecknas. De identifierade koderna grupperades utifrån likheter vilket resulterade i ett antal övergripande teman. Dessa teman jämfördes mellan intervjuerna för att säkerställa att de återkom i flera datakällor och därmed representerade centrala mönster i materialet. Dessa teman låg sedan till grund för det kommande designarbetet.

4.4 Utprovning

Evaluative research används för att undersöka hur användare uppfattar och reagerar på en gestaltning eller prototyp. Metoden syftar till att utvärdera om en design upplevs som användbar och begriplig genom att samla in feedback från potentiella användare (Martin & Hanington, 2012, 34. Evaluative research). Metoden används ofta iterativt, där återkoppling från användare används för att utveckla designen i flera omgångar. Det är vanligt med användartester där deltagare får interagera med en prototyp och beskriva sina upplevelser och tolkningar.

4.5 Metodkritik

De metoder som använts i studien har vissa begränsningar som bör beaktas vid tolkning av resultaten. Genomgången av informationsmaterial från organisationer och myndigheter avgränsades till ett urval av tillgängligt material för rätt åldersgrupp. Det innebär att det inte går att dra slutsatser om hela utbudet av befintligt informationsmaterial riktat till barn. Urvalet av barnböcker baserades på tillgänglighet vid två specifika bibliotek, vilket innebär att relevanta titlar kan ha uteslutits. Analysen av böckerna bygger på en mall som är inspirerad av tidigare forskning men anpassad för denna studie, vilket innebär att andra analysverktyg delvis hade kunnat ge andra resultat. Analysmallen som har använts finns i sin helhet i bilaga 10.1.

Även intervjuurvalet har vissa begränsningar. Det påbörjades som ett bekvämlighetsurval och utvecklades sedan via snöbollsmetoden, vilket innebär att urvalet inte är representativt för alla föräldrar till barn i målgruppen. Deltagarnas perspektiv kan ha påverkats av deras specifika erfarenheter och bakgrund. Antalet intervjupersoner är begränsat till fyra, vilket gör det svårt att dra generaliserbara slutsatser. Resultaten ger snarare en fördjupad förståelse för ett fåtal personers perspektiv och erfarenheter.

Intervjuer och utprovning ämnar genomförs med vuxna deltagare och inte med barn i målgruppen, vilket innebär att materialets faktiska effekt på barn inte kan utvärderas.

5 Förstudie

Kommande avsnitt redovisar datainsamlingen som gjordes i förstudien. En sammanfattning av analys och resultat presenteras.

5.1 Insamling av data

Omvärldsanalysen inleddes med en genomgång av informationsmaterial riktat till barn från ett urval av organisationer och myndigheter, däribland Lilla krisinfo, Rädda barnen, Mina rättigheter och Jag vill veta. Materialet granskades utifrån hur information om svåra ämnen utformas för yngre barn, med fokus på språk, bildanvändning och informationsinnehåll.

Därefter analyserades tio barnböcker om cancer med hjälp av den analysmall som återfinns i bilaga 10.1. Varje bok lästes igenom och granskades utifrån mallens kategorier: struktur och innehåll, språk, visuell kommunikation, trygghet och rädsla samt målgruppsanpassning. Varje verk granskades utifrån samma kriterier, vilket gjorde det möjligt att jämföra böckerna och identifiera återkommande mönster i hur cancer framställs i material riktat till barn.

Tre semistrukturerade intervjuer genomfördes med föräldrar till barn i målgruppen. Frågorna som ställdes finns i bilaga 10.3 och behandlade exempelvis erfarenheter kring befintlig information om sjukdom riktad till barn, vad intervjupersonerna själva hade velat ha för material som stöd i svåra samtal och hur de tycker information till barn bör utformas för att barnet ska känna trygghet. En intervju genomfördes ansikte mot ansikte och tog 25 minuter. Resterande två genomfördes digitalt via zoom och tog 13 respektive 30 minuter.

Ytterligare en semistrukturerad intervju genomfördes med en författare som har skrivit en barnbok om cancer, som även är tänkt att kunna användas som underlag till samtal med barn när någon i deras närhet drabbas av allvarlig sjukdom. Intervjun genomfördes via telefon och tog ca 20 minuter. I denna intervju riktades frågorna mer mot hur man kan tänka när man anpassar information till barn. Frågorna återfinns i bilaga 10.4. Denna intervju kompletterade föräldraintervjuerna genom att bidra med erfarenhet av att utforma information för barn.

Samtliga deltagare informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att deras svar behandlas anonymt.

5.2 Analys av data

5.2.1 Omvärldsanalys

Analysen av det informationsmaterial som riktar sig till barn från organisationer och myndigheter visar att sådant material generellt är begränsat när det gäller sjukdom. Mycket av det material som finns som behandlar sjukdom är riktat till vuxna med råd om hur de ska kommunicera med barn, snarare än till barnet självt. Detta tyder på att det finns ett gap i utbudet av information som talar direkt till barnet om svår sjukdom. Däremot finns det flera aspekter att ta med sig i gestaltningen, inte minst hur språket kan anpassas för att göra svåra ämnen mer begripliga och samtidigt skapa en känsla av trygghet hos barnet.

Analysen av de tio barnböckerna visar att cancer som ämne behandlas på varierande sätt, men att vissa mönster är återkommande. Informationen är i de flesta fall konkret och direkt även om den är väldigt förenklad, vilket stämmer överens med vad forskning visar om barns behov av tydlig och begriplig information. Att använda uttryck och ordval som barnet kan förstå bidrar till ethos (Lindqvist, 2016, s.84). Att uttrycka sig på ett sätt som inte är för svårt för mottagaren att ta till sig gör att författaren framstår som pålitlig jämfört med om det inte går att förstå textens innehåll.

Logos framträder i hur böckerna strukturerar den faktabaserade informationen. Sjukdomsförloppet presenteras i kronologisk ordning vilket skapar igenkänning. Genom att förklara orsak och verkan, som till exempel att man kan tappa håret av cellgifterna, ges barnet en logisk förståelse för vad som händer. Enligt Lindqvist (2016, s.82) stärks ett budskap av att man visar bevis för sina påståenden.

Illustrationerna fyller främst en förstärkande funktion. De konkretiserar och skapar igenkänning snarare än att tillföra ny information. Detta kan kopplas till Kress och van Leeuwens (2006, s.18) beskrivning av förankring, där texten begränsar bildens tolkningsutrymme och pekar ut vad betraktaren ska lägga märke till. Ikoniska illustrationer är vanligt förekommande, det vill säga att det finns en likhet med det som avbildas (Chandler, 2022, s.43). Det bidrar till att bilderna blir lätta för ett barn att tolka. Att illustrera vardagliga situationer som barnet känner igen är även något som stämmer väl överens med frågor som togs upp i samtliga intervjuer.



Figur 1 Uppslag från boken När mormor fick cancer av Minna Paananen. Illustratör: Elisabeth Widmark



Figur 2 Sida från boken En dum knöl i mammas bröst av Annie Hagvall Einarsrud. Illustratör: Hanna Ingvarsson

Ett återkommande mönster är att närvaron av trygga vuxna används som ett grepp för att hantera svåra känslor. I figur 1 som är ett uppslag från boken *När mormor fick cancer* (Paananen, 2015, s.12–13) sitter en mamma och ett barn och pratar vid matbordet efter att barnets mormor fått ett sjukdomsbesked. Mamman förklarar vad cancer innebär och berättar att man kan dö om cancern sprider sig för mycket. Trots att samtalet behandlar tunga ämnen framställs situationen som lugn, och barnet får stöd och svar på sina frågor av mamman. I figur 2 som kommer från boken *En dum knöl i mammas bröst* (Hagvall Einarsrud, 2022, s.21) sitter ett barn bredvid en sjuksköterska som svarar på barnets frågor. Även här fungerar den vuxna som ett tryggt stöd för barnet. Detta kan retoriskt kopplas till pathos. Genom att gestalta omsorg och närvaro skapas en emotionell trygghet som gör den svåra informationen mer hanterbar för barnet.

Döden hanteras försiktigt och undviks helt i de flesta böcker, vilket kan tolkas som ett sätt att balansera informationsbehov mot trygghetsskapande. Att undvika döden som ämne kan visserligen minska omedelbar oro, men riskerar samtidigt att lämna barnet oförberett om sjukdomen försämras.

Analysen visar att de flesta barnböcker om cancer är uppbyggda kring en berättelse med faktainslag av varierande omfattning. Det finns alltså utrymme för ett material som kombinerar ett narrativ med tydliga och konkreta fakta, och som är utformat för att kunna användas som ett stöd i samtal snarare än enbart som en berättelse att läsa.

5.2.2 Intervjuer

Intervjuerna bekräftar och fördjupar flera av de mönster som identifierades i omvärldsanalysen. Ett genomgående tema är behovet av ett enkelt språk anpassat till barnets nivå, utan medicinska termer. Flera av deltagarna nämner att informationen bör vara kortfattad och konkret, och att man med fördel kan dra paralleller till saker som finns i barnets vardag för att göra abstrakt information mer relaterbar.

Samtliga deltagare lyfter vikten av bilder och visuella element. Flera betonar att tecknade bilder gör informationen mer lättillgänglig och mindre skrämmande än fotografiska bilder, och att det visuella kan bära mer av budskapet än texten. En av deltagarna föreslår att man kan personifiera sjukdomen för att göra den begriplig, exempelvis som ett åskmoln som krymper i takt med behandlingen. Detta är ett exempel på ett ikoniskt tecken, där visuell likhet med något som barnet känner igen gör abstrakt information mer konkret och lättare att tolka. (Chandler, 2022, s.43). Bilder upplevs som ett viktigt stöd till texten både för att de kan hjälpa till att konkretisera situationer som annars kan vara svåra för ett barn att förstå, och även för att barn som inte kan läsa så bra ännu kan följa med i handlingen med hjälp av bilderna. Detta stämmer överens med vad Rakower och Hallyburton (2022) visar om att kombinationen text och bild gör information tillgänglig även för de som har begränsad läsförmåga.

Narrativ struktur efterfrågas av samtliga deltagare. Man föredrar information som presenteras som en berättelse med igenkännbara situationer snarare än som ren fakta, och flera nämner vikten av att visa barnets perspektiv och

vardagliga miljöer. Genom att följa en familj i en specifik situation kan innehållet bli mer relaterbart och lättare att ta till sig. Detta stämmer väl överens med vad Abbott (2021, s.46) och Ku et al. (2025) säger om narrativets och storytellingens effekt på barns förståelse och känslobearbetning.

Kring frågan om döden råder delade meningar. Tre av fyra deltagare menar att ämnet bör nämnas för att förbereda barnet på vad som kan hända, medan den deltagare som har egen erfarenhet av cancer betonar att man inte bör introducera frågor som barnet ännu inte ställt. Samtliga är dock överens om att man bör svara ärligt om barnet frågar. Denna balansgång återspeglas i omvärldsanalysens observation att döden ofta undviks i böcker för målgruppen.

Behovet av ett material som fungerar som stöd i samtal är tydligt. Flera deltagare beskriver hur man som förälder i en krissituation kan ha svårt att hitta rätt ord, och att ett material att luta sig mot och återkomma till kan vara ett konkret stöd. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att föräldrar ofta vill vara öppna i sin kommunikation men känner osäkerhet kring hur informationen bör delas (Alfieri et al., 2026; Kenny et al., 2021). Forskning visar även att material riktat till familjer bidrar till en mer öppen kommunikation och hjälper barnet att förstå förälderns situation, vilket i sin tur stärker barnets välmående (Yamaji et al., 2022; Zhao et al., 2024).

5.2.3 Sammanfattning

Omvärldsanalysens och intervjuerna bekräftar varandra på flera centrala punkter. Både analysen av befintliga barnböcker och intervjuerna visar att information om cancer till barn behöver vara konkret, språkligt tillgänglig och fri från medicinska termer. Bildernas roll lyfts i båda datakällorna som central. Illustrationer bidrar till igenkänning och hjälper barn att förstå situationer som annars kan vara svåra att greppa.

Ett återkommande tema i både omvärldsanalysen och intervjuerna är balansgången mellan att ge tydlig och ärlig information och samtidigt skapa trygghet och undvika onödig oro. Detta återspeglas bland annat i hur döden hanteras. Omvärldsanalysen visar att ämnet ofta undviks i bilderböcker, vilket stämmer överens med en av intervjudeltagarnas perspektiv. Samtidigt betonar tre av fyra deltagare vikten av att inte undvika svåra ämnen, vilket antyder att det finns en efterfrågan på ett mer öppet förhållningssätt än vad befintligt material erbjuder. Intervjuerna lyfter fram ett tydligt behov av material som fungerar både för barnet och som stöd för vuxna i samtal. Även om enstaka böcker i omvärldsanalysen är utformade med det dubbla syftet i åtanke, visar intervjuerna att föräldrar efterfrågar ett material som är mer explicit utformat för att stödja samtal. Man vill ha något att luta sig mot och som man kan återkomma till tillsammans med barnet.

5.3 Resultat

Analysen av intervjuerna resulterade i fem centrala teman som återkommer i samtliga intervjuer. Temana speglar deltagarnas erfarenheter och perspektiv på hur information om cancer bör utformas för barn, och stämmer väl överens med vad tidigare forskning visar om barns informationsbehov och kommunikation om svår sjukdom. Tabellen nedan sammanfattar temana och deras innehåll.

Tema	*Innehåll*	*Antal*
Förenkling och konkret språk	Språket behöver vara anpassat till barnets nivå, undvika medicinska termer, kortfattat och konkret, förklara det som är abstrakt.	4/4
Visuell kommunikation	Mycket bilder, bilderna viktigare än text, visuellt stöd hjälper förståelse, visualisera processer.	4/4
Narrativ struktur	Informationen presenteras som en berättelse i stället för bara fakta, saker från vardagen att relatera till, visa familjesituationer, barnets perspektiv.	4/4
Trygghet	Alla känslor är okej, trygghet genom tydlighet och förberedelse, balans mellan att inte skrämma men inte försköna, svara på frågor.	4/4
Stöd i kommunikation	Material som kan läsas på egen hand eller tillsammans, stöd för föräldrar i samtal, något att luta sig tillbaka på och återkomma till.	4/4

Figur 3 Tabell över teman från intervjuresultat

Antal avser hur många av intervjudeltagarna som tog upp respektive tema.

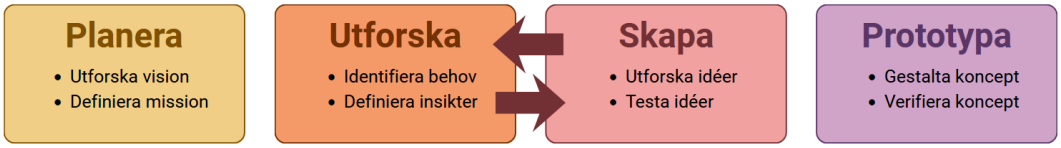
Förstudiens resultat visar sammantaget att det finns ett behov av informationsmaterial om cancer som är anpassat för barn i åldern 6–9 år och som samtidigt kan fungera som stöd för vuxna i samtal om sjukdomen. Både omvärldsanalysen och intervjuerna pekar på att informationen behöver vara konkret och språkligt tillgängligt, inte använda medicinska termer och använda en narrativ ram som visar igenkännbara situationer och barnets perspektiv. Illustrationer spelar en central roll för att göra informationen begriplig och trygg, och bör vara utformade så att de är lätta för barn att tolka.

Förstudien visar också att det finns ett gap i befintligt material. Många av de barnböcker som finns är i första hand berättelser med varierande faktainslag, och få är explicit utformade för att fungera som samtalsstöd. Intervjuerna visar att föräldrar efterfrågar just detta, ett material som är riktat till barnet men som också ger den vuxne något att luta sig mot och återkomma till. Dessa insikter har legat till grund för det gestaltningsarbete som beskrivs i nästa avsnitt.

6 Designprocess

Detta avsnitt redogör för processen bakom gestaltningen och de designval som gjordes under arbetets gång. Utprovningar av materialet beskrivs.

Wikberg Nilsson et al. (2021, 30–31) beskriver en designprocess som en serie steg med aktiviteter för att uppnå ett mål eller ett uppdrag. Författarna beskriver vidare att det som är gemensamt för alla designprocesser är att de går igenom ett visst förlopp för att utvecklas och nå målet.



Figur 4 Visualisering av designprocessen. Källa: Wikberg Nilsson et al (2021, s.31)

De olika stegen i designprocessen innebär att planera projektet, utforska kontext genom att identifiera behov, skapa idéer och till sist gestalta och visualisera ett koncept för att komma fram till en lösning (Wikberg Nilsson et al, 2021, s.31).

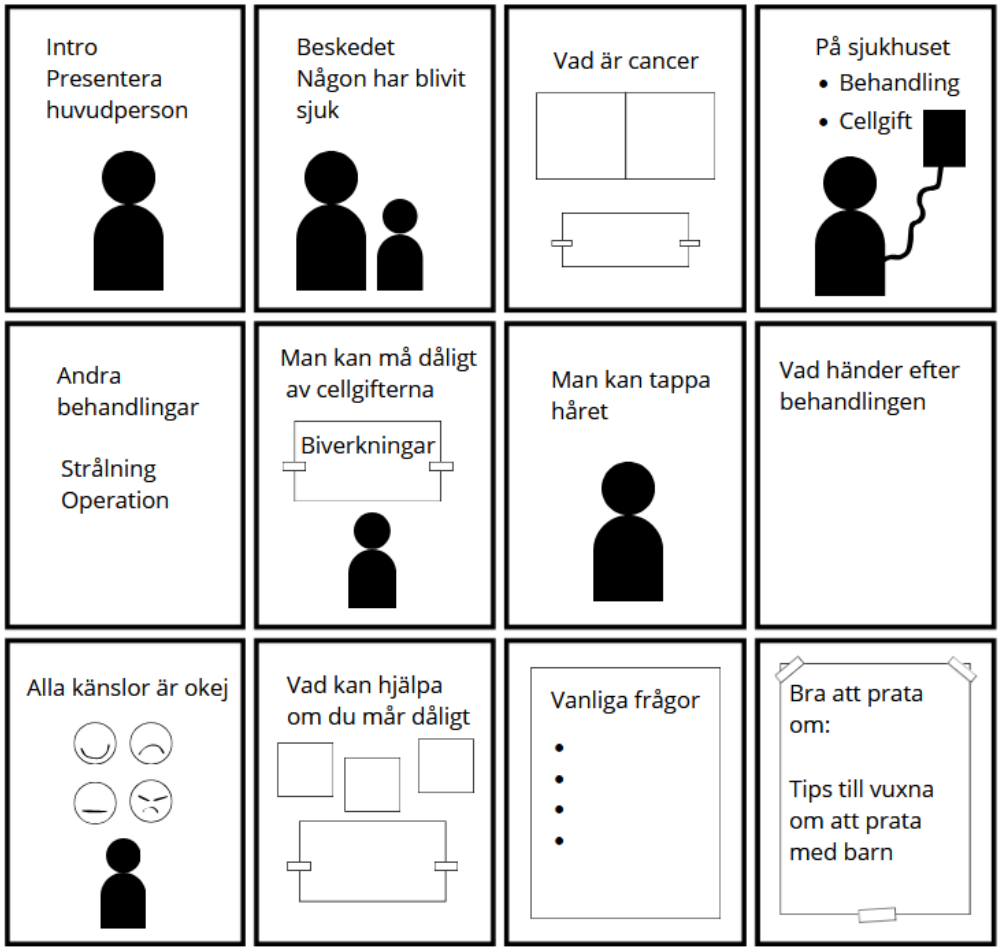
Processen i det här arbetet inleddes med en omvärldsanalys för att ta reda på vilken information som finns om ämnet som är riktat till målgruppen. Därefter genomfördes intervjuer för att identifiera vilka behov som finns.

Gestaltningsarbetet inleddes sedan med att skissa för att testa idéer kring innehållets struktur. Skisserna användes för att planera hur informationen kunde organiseras och hur narrativet kunde byggas upp. Dessa skisser resulterade i en sidplan med en struktur för allt innehåll. Som figur 4 visar har processen varit iterativ, där arbetet växlade mellan att utforska behov och att skapa och testa idéer. Insikter från intervjuer, omvärldsanalys och utprovningar användes löpande för att vidareutveckla gestaltningen.

Gestaltningen avgränsades till två uppslag som valdes ut eftersom de tydligast representerade studiens fokus på narrativa, retoriska och visuella strategier. Dessa två uppslag skissades mer noggrannt för att planera för vilken information som var viktig att ta med och hur text och bild skulle samspela. Utifrån skisserna skapades prototyper där resultaten från omvärldsanalysen och intervjuerna användes som grund för innehåll och utformning. Uppslagen skapades i indesign, och användes sedan vid utprovning med vuxna personer som skulle kunna använda gestaltningen som stöd i samtal med barn i målgruppen. Utifrån deltagarnas feedback gjordes justeringar som sedan resulterade i den färdiga gestaltningen.

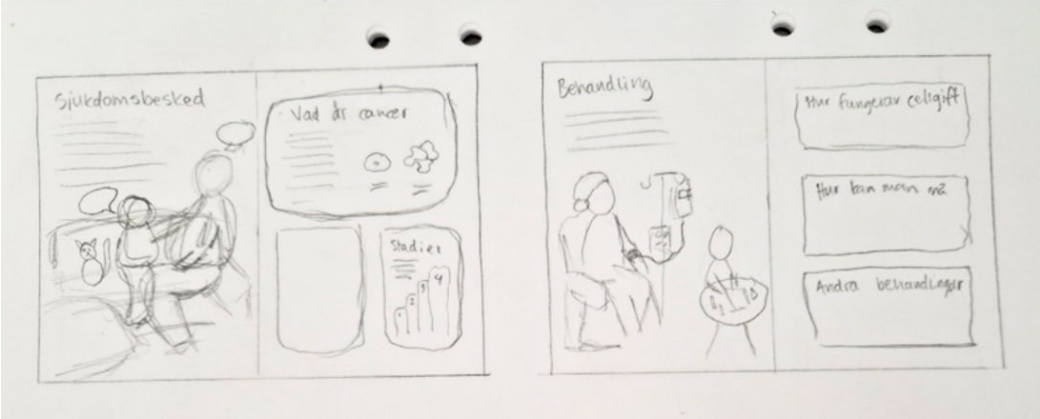
6.1 Skisser

Arbetet började med en övergripande sidplan. Den användes för att planera materialets struktur, dramaturgi och innehållsfördelning. Materialet är planerat att omfatta 16 sidor inklusive omslag. Omslaget och omslagets insidor visas inte i sidplanen.



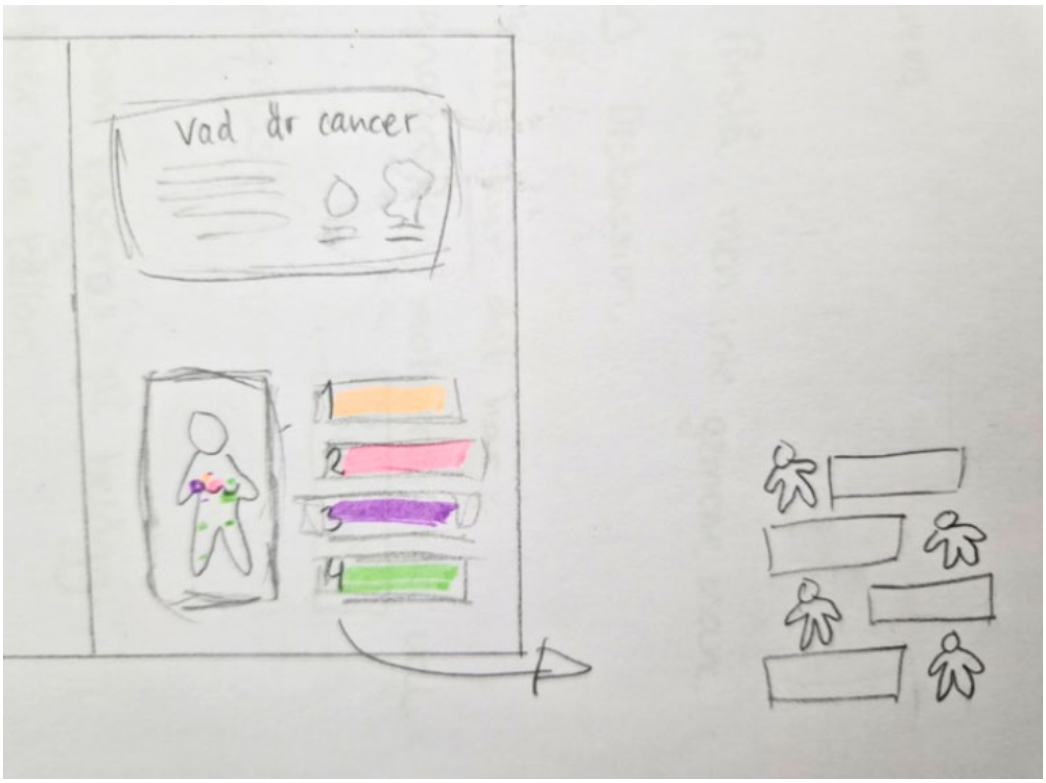
Figur 5 Sidplan över innehållets planerade struktur. Upphovsperson: Tina Håkansson

Därefter utvecklades mer detaljerade skisser av enskilda uppslag. I dessa testades bland annat samspelet mellan berättande text och faktadelar, placering av illustrationer samt hur visuella element kunde användas för att stödja förståelsen av innehållet. Skisserna användes även för att utforska hur sjukhusmiljöer och medicinska processer kunde gestaltas på ett sätt som upplevs trygghetsskapande för barn.



Figur 6 Mer detaljerade skisser av enskilda uppslag. Upphovsperson: Tina Håkansson

Under skissprocessen testades även olika sätt att visualisera medicinsk information på ett mer begripligt sätt för målgruppen. Ett exempel är illustrationen av cancerns olika stadier, där färgkodning och förenklade former användes för att skapa en tydlig och lättförståelig översikt. Syftet var att konkretisera abstrakt information och samtidigt behålla ett visuellt uttryck som inte upplevs skrämmande för barnet.



Figur 7 Skissutveckling av visualisering av cancerns olika stadier. Upphovsperson: Tina Håkansson

Skisserna låg därefter till grund för utvecklingen av digitala prototyper i InDesign. I prototyperna vidareutvecklades layout, färgpalett, typografi och samspelet mellan text och bild. Prototyperna användes sedan vid utprovningarna där deltagarnas feedback låg till grund för vidare justeringar av gestaltningen.



Figur 8 Första prototypen av uppslag 1. Upphovsperson: Tina Håkansson



Figur 9 Första prototypen av uppslag 2. Upphovsperson: Tina Håkansson

6.2 Designval

6.2.1 Format

Materialet har utformats i bilderboksformat, där text och bild samverkar på varje uppslag. Formatet motiveras av Batemans (2014, s.88) beskrivning av bilderbokens dubbla orientering, vilket innebär att text och bild kan läsas var för sig men tillsammans skapar en rikare berättelse. Det möjliggör att barn och vuxna kan ta del av samma material på olika nivåer. Detta stämmer överens med intervjuresultaten som visade att föräldrar efterfrågar ett material som fungerar både för barnet självt och som stöd i samtal.

Rakower och Hallyburton (2022) visar att kombinationen text och bild gör information tillgänglig även för de med begränsad läsförmåga, vilket är särskilt relevant för de yngre barnen i målgruppen. Även om barnet inte förstår texten kan det ändå förstå mycket av sammanhanget med hjälp av bilderna. Formatet möjliggör också en balans mellan narrativ och fakta på samma uppslag, vilket är centralt för materialets dubbla syfte.

6.2.2 Informationsurval

Gestaltningen omfattar två uppslag som valdes ut för att belysa de delar av informationsförloppet som är mest relevanta för studiens forskningsfråga, hur man kan förklara cancer på ett begripligt och trygghetsskapande sätt för barn med hjälp av narrativa och retoriska principer. Uppslag där informationsinnehållet inte bedömdes bidra lika tydligt till studiens syfte valdes därför bort från gestaltningen. Övriga delar av det tänkta materialet redovisas i form av en sidplan (se figur 5).

Faktainnehållet i materialet är hämtat från medicinskt tillförlitliga källor. Information om cancer och bröstcancer baseras på 1177 (2023) och Bröstcancerförbundet (2025, 2026), och har förenklats och anpassats språkligt för att vara begriplig för målgruppen utan att vara medicinsk felaktig.

6.2.3 Att skriva för barn

Som stöd för att utforma texterna i gestaltningen har Lilla Krisinformations skrivguide *Att skriva för barn om kriser* (2024) använts. De påtalar till exempel att man ska skriva på ett sätt som är tydligt och respektfullt, samtidigt som det visar hur barnet kommer påverkas av det man skriver om (Lilla krisinformation, 2024, s.4). Enligt lilla krisinformation (2024, s.8) är det dessutom viktigt att inte använda svåra ord, vilket stämmer med resultaten från intervjuerna. Man beskriver svåra ord som allt man behöver fundera på, och menar alltså att det är viktigt att man ska förstå alla ord direkt. Man tar även upp storytelling som ett effektivt sätt att förmedla information om svåra ämnen på ett engagerande sätt (Lilla krisinformation, 2024, s.14), vilket stämmer överens med vad Ku et al (2025) kom fram till i sin studie om storytellingens effekter på barn.

I gestaltningen har dessa principer omsatts genom ett enkelt och direkt språk med korta meningar och vardagliga formuleringar. Medicinska termer har i stor

utsträckning undvikits eller förklarats med hjälp av konkreta exempel och visuellt stöd. Texterna är även skrivna med fokus på att vara ärliga utan att bli dramatiska, vilket syftar till att skapa en balans mellan tydlig information och trygghet för barnet. Narrativ och storytelling används genomgående som ett sätt att förankra fakta i igenkännbara situationer och göra innehållet mer relaterbart för målgruppen.

6.2.4 Typografi

Typografin i materialet har valts med fokus på läsbarhet och tydlighet. Sanserif-typsnitt används genomgående i materialet, men med olika typsnitt och grader för berättande text respektive faktadelar. Berättelsesidorna använder Ebrima i 12 punkter med 17 punkters radavstånd för att skapa en luftig och lättläst löptext vid högläsning. På faktasidorna används Roboto i 10 punkter med 14 punkters radavstånd, vilket möjliggör tydliga och överskådliga faktarutor utan att textmängden upplevs för kompakt.

Hellmark (2004, s. 26–27) beskriver att antikva ofta lämpar sig väl för längre löptexter, medan sanserif-typsnitt fungerar särskilt bra i kortare texter samt i diagram och informationsgrafik. Eftersom gestaltningen kombinerar kortare berättande text med faktarutor och visuella element bedömdes sanserif vara ett lämpligt val för att skapa ett enhetligt uttryck samtidigt som läsbarheten bibehålls för målgruppen. Hellmark (2004, s.30) beskriver vidare att läsbarheten ofta förbättras mer genom ökat radavstånd än genom att enbart öka textstorleken, vilket har påverkat valet av radavstånd i gestaltningen.

6.2.5 Narrativ

Utifrån förstudiens resultat och tidigare forskning identifierades flera centrala principer för gestaltningen. Intervjuerna visade att deltagarna föredrog information presenterad som en berättelse snarare än som ren fakta, vilket stämmer överens med vad Ku et al. (2025) visar om storytellingens effekt på barns förmåga att bearbeta svår information. Abbott (2021, s.46) beskriver hur narrativ inte bara förmedlar innehåll utan även formar hur innehållet upplevs, vilket motiverar valet att strukturera information kring ett narrativ. Materialet är uppbyggt kring ett händelseförlopp som följer en kronologisk ordning. Detta gör det lättare för barnet att förstå vad som händer och varför.

Den narrativa texten är skriven ur barnets perspektiv i första person, vilket syftar till att skapa identifikation och igenkänning hos läsaren. Att berätta ur barnets synvinkel kan även bidra till att avdramatisera situationen. Barnet ser att någon annan är med om samma sak, vilket kan minska känslan av att vara ensam i en svår situation.

6.2.6 Retorik

Ethos etableras bland annat genom att fakta är hämtad från medicinskt tillförlitliga källor som 1177 och bröstcancerförbundet. Texten är konkret utan att vara dramatisk och medicinska termer förklaras eller undviks helt, vilket gör att materialet framstår som trovärdigt även för yngre barn.

Pathos framträder i de narrativa illustrationerna och i hur berättartexten är skriven. Illustrationerna är vardagliga för att väcka igenkänning och trygghet. Berättelsen är skriven ur barnets perspektiv, vilket skapar identifikation och gör det emotionellt lättare att ta in svår information. Att exempelvis avsluta stycket om biverkningar med att håret växer tillbaka är ett medvetet val för att balansera svår information med hopp.

Logos syns i hur informationen är strukturerad. Förklaringarna är konkreta och ger barnet en logisk förståelse för vad som händer. Informationen presenteras i en ordning som följer sjukdomsförloppet, från sjukdomsbesked till behandling, vilket skapar begriplighet och förutsägbarhet.

6.2.7 Semiotik

Illustrationerna föreställer vardagliga situationer man kan hamna i under ett sjukdomsförlopp. Bilderna är ikoniska i Peirces bemärkelse eftersom de bygger på visuell likhet med en igenkännbar situation, vilket gör dem lätta för barn att tolka.

Färgkodningen av de fyra cancerstadierna fungerar som ett symboliskt tecken. Färgerna har ingen naturlig koppling till stadierna utan får sin betydelse genom hur de används i illustrationen för att skilja stadierna åt.

Illustrationerna kommunicerar på både denotativ och konnotativ nivå. De visar konkreta situationer som ett barn och en mamma som sitter i en soffa eller en behandling på sjukhus, samtidigt som färgval, formspråk och motiv förmedlar känslor av trygghet och igenkänning. Detta kan bidra till att den svåra informationen upplevs som mindre skrämmande för barnet.

6.2.8 Visuell kommunikation

Text och bild förhåller sig till varandra på olika sätt i materialet. På de narrativa sidorna fungerar text och bild i ett reläförhållande, där de kompletterar varandra och bygger tillsammans upp berättelsen (Kress & van Leeuwen, 2006, s.18). På faktasidorna används i stället förankring. Faktarutor och rubriker styr hur illustrationerna ska förstås och begränsar deras tolkningsutrymme (Kress & van Leeuwen, 2006, s.18). Detta syns exempelvis i illustrationen av cancerns olika stadier, där texten förtydligar vad de olika färgmarkeringarna och formerna representerar. Texten fungerar som en läsanvisning som hjälper mottagaren att tolka bildens innehåll på avsett sätt, vilket Eriksson (2017, s.84) beskriver som viktigt i visuell kommunikation.

Kombinationen av text och bild är central för att göra informationen tillgänglig för målgruppen. Rakower och Hallyburton (2022) visar att text och bild i kombination gör information tillgänglig även för de som har begränsad läsförmåga, vilket är särskilt relevant för de yngre barnen i spannet 6–9 år som

kanske inte läser flytande ännu. Forskning visar även att material riktat till familjer bidrar till en mer öppen kommunikation och stärker barnets välmående (Yamaji et al., 2022), vilket motiverar valet att utforma materialet för både barn och vuxna. Samspelet mellan text och bild används alltså inte enbart för att förmedla information, utan också för att skapa trygghet och stödja samtal.

6.3 Utprovning

För att undersöka hur gestaltningen uppfattas och fungerar genomfördes utprovningar med tre personer. Syftet var att identifiera eventuella oklarheter samt att undersöka deltagarnas upplevelse av materialet. Utprovningen ämnade genomföras enbart med vuxna personer.

Utprovningen genomfördes individuellt för att möjliggöra personliga reflektioner utan påverkan från andra deltagare. Deltagarna är dels personer som har deltagit i intervjuer i förstudien, dels en person som inte har någon tidigare insyn i projektet. Urvalet gjordes för att både få återkoppling från personer som har kännedom om projektet samt för att testa gestaltningen på en ny läsare.

Under utprovningen fick deltagarna ta del av gestaltningens uppslag och beskriva sina tankar. Det ställdes även frågor kring exempelvis förståelse och innehåll. Utprovningen genomfördes som en iterativ process där de tidiga testerna ligger till grund för vissa justeringar innan ytterligare test.

6.3.1 Utprovning 1

Den första utprovningen genomfördes med en av intervjudeltagarna från förstudien.

Det övergripande intrycket av materialet var positivt. Deltagaren upplevde färgvalet som lugnande och betryggande, och illustrationerna beskrevs som varma och hemtrevliga snarare än sterila. Sjukhusmiljön på det andra uppslaget lyftes specifikt fram som ett lyckat val eftersom den inte upplevdes som skrämmande.

Samspelet mellan berättelsen och faktadelarna upplevdes som bra. Deltagaren betonade värdet av att fakta och narrativ presenteras tillsammans, och menade att mängden text upplevdes som lagom. En styrka som lyftes fram var att materialet kan användas flexibelt beroende på barnets ålder och förståelse eftersom en vuxen kan välja att visa hela uppslaget eller fokusera på enskilda delar.

Materialet bedömdes fungera väl som stöd i samtal med barn. Deltagaren beskrev det som bra att fakta finns tillgänglig i förenklad form, vilket gör det lättare för den vuxne att anpassa nivån i samtalet utifrån barnets behov.

Under utprovningen föreslog deltagaren spontant att läsa materialet högt för sitt barn som befann sig i hemmet. Barnet lyssnade när den vuxne läste högt och verkade följa med i berättelsen. Barnets reaktioner gav intrycket av att

innehållet gick att följa utan att situationen verkade obehaglig. Ett förbättringsförslag framkom kring ordet "biverkningar" som kan vara svårt för yngre barn att förstå. Det diskuterades om ordet borde bytas ut eller förklaras tydligare i texten.

Eftersom barnet deltog spontant på initiativ av sin vårdnadshavare gavs samtycke av den person som ansvarade för barnet. Barnet tillfrågades om det ville läsa tillsammans med sin förälder och informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, detta för att säkerställa att deltagandet skedde på barnets villkor. Barnets reaktioner observerades löpande och inga tecken på obehag noterades, vilket enligt Vetenskapsrådet (2024, s. 64) är viktigt att vara uppmärksam på när barn involveras i forskning.

Efter utprovningen ändrades ordet ”biverkningar” till ”känna sig sjuk”. Testpersonen stakade sig lite vid läsning av ”de” och ”dem”, så båda dessa ord ändrades till ”dom” enligt rekommendation från lilla krisinformations skrivguide (2024).

6.3.2 Utprovning 2

Även den andra utprovningen genomfördes med en av intervjudeltagarna från förstudien.

Materialet upplevdes som väl anpassat för barn. Deltagaren påtalade att språket var lätt att förstå då det inte innehåller sjukhustermer och svåra ord. Mängden text upplevdes som lagom, och deltagaren nämnde att det kan vara svårt för ett barn att hänga med om det är för mycket text.

Deltagaren upplevde vidare att berättelsen och faktadelarna hade en tydlig koppling. Illustrationerna var enkla att förstå, och specifikt att cancercellerna såg ledsna ut uppskattades då det speglar att något inte står rätt till utan att upplevas som skrämmande.

Ändringarna efter den tidigare utprovningen diskuterades, och deltagarna höll med om att ”biverkningar” skulle kunna vara svårt för yngre barn att förstå. Utöver det tyckte deltagaren inte att det fanns fler ord som var svåra att förstå. Eftersom inga ytterligare förbättringsförslag framkom gjordes inga justeringar av materialet inför nästa utprovning

6.3.3 Utprovning 3

Den tredje utprovningen genomfördes med en person som inte hade deltagit i förstudien och som inte hade någon tidigare insyn i projektet.

Det övergripande intrycket var positivt. Deltagaren upplevde illustrationerna som enhetliga och fina, och beskrev färgvalet som lugnt och harmoniskt. Samspelet mellan berättelsen och faktadelarna upplevdes som tydligt, och uppdelningen med berättelse på vänstersidan och fakta på högersidan lyftes fram som ett lyckat val som gör materialet lätt att följa.

Mängden text upplevdes som lagom. Deltagaren menade att det är fördelaktigt att texten är något mer utförlig när materialet är tänkt att läsas högt, eftersom

det ger den vuxne ett färdigt underlag att utgå från utan att behöva hitta på egna formuleringar.

Cellillustrationen lyftes fram som ett bra pedagogiskt val, och deltagaren noterade att den ledsna cancercellen tydligt signalerar att något är fel, men utan att vara skrämmande. Illustrationerna av cellgiftsfigurerna upplevdes inte som konstiga eller svårtolkade.

Materialet bedömdes fungera väl som samtalsstöd. Deltagaren menade att det blir lättare att berätta om man har något konkret att visa samtidigt, och att illustrationernas mjuka stil bidrar till att lätta upp ett svårt samtal.

Två förbättringsförslag framkom. Det första gällde textstorleken på högersidan som upplevdes som något liten, men deltagaren påpekade att det är svårt att bedöma på skärm och att det inte påverkade läsbarheten märkbart. Det andra gällde att ordet "läkare" eventuellt kan ersättas med "doktor" eftersom det är ett mer bekant ord för barn.

6.3.4 Sammanfattning

Samtliga tre utprovningar visade ett positivt övergripande intryck av materialet. Återkommande hos alla tre var att illustrationerna upplevdes som varma och passande för målgruppen, att mängden text kändes lagom och att uppdelningen mellan berättelse och fakta upplevdes som tydlig och funktionell. Materialets funktion som samtalsstöd bekräftades av samtliga deltagare, som betonade värdet av att ha ett konkret underlag att utgå från i ett svårt samtal.

De iterativa justeringar som gjordes utifrån utprovningarna gällde framför allt språklig tillgänglighet. Ordet "biverkningar" ersattes med en mer konkret formulering, och ordet läkare ersattes med doktor. Pronomenen "de" och "dem" ändrades till "dom" i enlighet med Lilla Krisinformations skrivguide (2024). Textstorleken på högersidan kontrollerades genom testutskrifter. De bedömdes ha bra läsbarhet, så de ändrades inte.

7 Gestaltningsförslag

I detta avsnitt presenteras det färdiga gestaltningsförslaget och hur det utformats utifrån arbetets syfte, teori och resultat.

Gestaltningsförslaget har utformats utifrån resultaten från förstudien samt tidigare forskning om barns informationsbehov. Förstudien visade att information om cancer behöver vara konkret, visuellt tydlig och berättad på ett sätt som skapar trygghet utan att undvika svåra ämnen. Tidigare forskning visar även att narrativa strukturer och storytelling kan hjälpa barn att förstå och bearbeta känslomässigt svår information (Ku et al., 2025), samt att kombinationen av text och bild kan göra information mer tillgänglig för barn med varierande läsförmåga (Rakower & Hallyburton, 2022).

Gestaltningsförslaget består av ett informationsmaterial i bilderboksformat riktat till barn i åldern 6–9 år, utformat för att kunna användas både av barnet självt och som stöd i samtal mellan barn och vuxna. Tidigare forskning visar att det finns ett behov av material som är riktat till barn och familjer (Zhao et al, 2024), och fokus har legat på att skapa ett material som är både begripligt och trygghetsskapande genom samspelet mellan narrativ, fakta och illustrationer.



Figur 10 Gestaltningsförslag uppslag 1. Upphovsperson: Tina Håkansson

Det första uppslaget introducerar sjukdomsbeskedet genom en vardaglig situation mellan barnet och mamman. Uppslaget är utformat för att skapa igenkänning och trygghet genom mjuka illustrationer och ett lugnt visuellt uttryck. Den narrativa texten är skriven ur barnets perspektiv för att underlätta identifikation hos läsaren.

På högersidan kombineras berättelsen med förenklad information om cancer. Faktadelarna är uppdelade i mindre sektioner med visuellt stöd för att göra informationen mer överskådlig och lättare att förstå. Text och bild fungerar här i ett förankrande förhållande där illustrationerna hjälper till att konkretisera informationen. Kombinationen av berättelse och fakta syftar till att skapa en balans mellan emotionellt stöd och konkret information, vilket var något som efterfrågades i intervjuerna i förstudien.



Figur 11 Gestaltningsförslag uppslag 2. Upphovsperson: Tina Håkansson

Det andra uppslaget fokuserar på behandling och biverkningar. Sjukhusmiljön gestaltas med mjuka former och varma färger för att minska känslan av rädsla och sterilitet, något som även lyftes fram positivt under utprovningarna.

Cancerceller och behandling visualiseras genom förenklade och personifierade illustrationer. Syftet är att göra abstrakta processer mer begripliga för barn genom ikoniska tecken och visuella metaforer. Samtidigt balanseras den jobbiga informationen genom att texten betonar att exempelvis håravfall är tillfälligt, vilket bidrar till ett mer trygghetsskapande tilltal.

Gestaltningsförslaget visar hur narrativa och visuella strategier kan användas för att göra information om cancer mer begriplig och trygghetsskapande för barn. Genom kombinationen av berättelse, fakta och illustrationer skapas ett material som både kan stödja barnets förståelse och fungera som stöd för vuxna i samtal om sjukdomen.

8 Diskussion och slutsats

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat och gestaltning i relation till teori, tidigare forskning och empiri. Avslutningsvis presenteras arbetets slutsatser.

8.1 Diskussion

Arbetet har undersökt hur information om cancer kan gestaltas för barn i åldern 6–9 år på ett sätt som gör informationen mer begriplig och trygghetsskapande. Resultatet visar att kombinationen av narrativa element, fakta och illustrationer kan bidra till att göra komplex och känslomässigt svår information mer tillgänglig för målgruppen. Genom samspelet mellan berättelse och visuella element skapades ett material som både kan stödja barnets förståelse och fungera som stöd i samtal mellan barn och vuxna.

Arbetet har även undersökt två underfrågor. Den första, vilka visuella och narrativa strategier som kan göra information begriplig för barn, besvarades genom att kombinera ett narrativ skrivet ur barnets perspektiv med ikoniska illustrationer av igenkännbara situationer. Semiotiken visade sig vara användbar för att förstå varför dessa illustrationer fungerar. Ikoniska tecken som bygger på visuell likhet är lättare för barn att avkoda, eftersom de inte kräver samma förkunskaper som mer abstrakta symboler. Detta gör dem särskilt användbara i gestaltning av medicinsk information, där tydlighet och trygghet är centralt. Ett exempel på detta var de figurer som skapades för att gestalta celler och cellgift. Idén om att visualisera dessa som karaktärer återkom i flera intervjuer i förstudien och uppskattades även av samtliga deltagare under utprovningarna. Figurerna bidrog till att göra informationen mer konkret och mindre skrämmande genom att visualisera abstrakta medicinska processer på ett lättillgängligt sätt.

De retoriska övertygelsemedlen visade sig användbara på olika sätt i gestaltningen, men inte alltid på lika enkla sätt. Logos framträdde tydligast i uppdelningen mellan narrativa sidor och faktasidor, där strukturen i sig kommunicerar vad som är berättelse och vad som är faktabaserad information. Pathos visade sig naturligast i de narrativa delarna, där berättarrösten och illustrationerna tillsammans skapar en känslomässig igenkänning som gör det lättare att ta in svår information. Ethos visade sig vara det mest komplexa att arbeta med. Trovärdighet etableras genom medicinskt tillförlitliga källor, men dessa är inte synliga i det färdiga materialet. Det väcker en fråga om hur man bör hantera källor i informationsmaterial för barn. Ska de vara synliga för att skapa trovärdighet, eller ska de hållas i bakgrunden för att inte störa läsupplevelsen?

Den andra underfrågan, hur materialet kan utformas för att fungera både för barnet och som stöd i samtal, besvarades genom bilderboksformatets dubbla orientering, som Bateman (2014) beskriver. Arbetet bekräftar det behov av

informationsmaterial riktat till barn och familjer som tidigare forskning identifierat (Yamaji et al., 2022; Zhao et al., 2024). Utprovningarna visade att materialet upplevdes fungera som ett konkret stöd i samtal, vilket stämmer väl överens med forskning som visar att sådant material kan bidra till en mer öppen kommunikation om sjukdom i familjen.

En central del i arbetet har varit balansen mellan att vara ärlig kring sjukdomen och samtidigt skapa trygghet för barnet. Information om cancer kan upplevas skrämmande och svår att förstå, särskilt för yngre barn som inte förstår innebörden av sjukdomen. Därför fokuserade gestaltningen på att visualisera informationen genom förenklade illustrationer och ett lugnt visuellt uttryck. Utprovningarna visade att deltagarna upplevde detta som positivt och att illustrationerna gjorde informationen lättare att förstå utan att materialet upplevdes alltför skrämmande.

Begreppet *cellgifter* som används i gestaltningen, kan enligt Cancerfonden (2019, s. 2) uppfattas som obehagligt. De rekommenderar i stället termen *cytostatika*, som används inom vården. Samtidigt indikerar samtliga intervjuer i studien att det är viktigt att undvika medicinska termer som barnet inte är bekant med, eftersom det kan försvåra förståelsen. Ordet *gift* kan trots eventuella negativa associationer fungera som en begriplig ingång för barn, eftersom det är välkänt i deras vardagliga språk. Genom att komplettera med en enkel förklaring av att behandlingen riktar sig mot att döda cancerceller kan informationen göras mer tillgänglig utan att kräva några förkunskaper. Detta bidrog till valet att behålla begreppet i gestaltningen.

En fråga som lyftes i intervjuerna var huruvida döden bör nämnas i materialet eller inte. Tre av fyra deltagare menade att ämnet bör beröras för att förbereda barnet på vad som kan hända, vilket också stämmer överens med forskning som visar att en effektiv kommunikation kring sjukdomen kan bidra till att barnet känner sig mer förberedd på det som sker (Yamaji et al., 2022). I de gestaltade uppslagen behandlas inte detta explicit, vilket inte innebär att ämnet aktivt valts bort utan snarare att det naturligt hör hemma i en annan del av materialets struktur. Frågan om döden hade kunnat få plats i uppslaget om vanliga frågor eller i det avslutande samtalsunderlaget riktat till vuxna, men dessa delar ingick inte i gestaltningen av avgränsningsskäl.

Narrativet blev också en viktig del av gestaltningen. Ku et al. (2025) beskriver hur narrativa strukturer kan hjälpa barn att förstå och bearbeta känslomässigt svår information, medan Rakower och Hallyburton (2022) lyfter fram hur kombinationen av text och bild kan öka tillgängligheten för barn med varierande läsförmåga. Detta syntes även i resultatet där samspelet mellan text och bild bidrog till ökad förståelse. Genom att låta berättelsen utgå från barnets perspektiv skapades större möjlighet för igenkänning hos läsaren. Samtidigt innebar detta en utmaning i att balansera mängden berättelse och information för att materialet inte skulle bli för texttungt och svårt att överblicka.

Begreppet *trygghetsskapande* är komplext och det är svårt att avgöra i vilken utsträckning ett material faktiskt skapar trygghet hos barn, särskilt när det inte har testats på barn i någon större utsträckning. Däremot visar forskning att en

effektiv kommunikation kring sjukdomen kan bidra till att barnet känner sig mer förberett på det som händer, samtidigt som brist på information kan minska tilliten till de vuxna som finns omkring barnet (Yamaji et al., 2022). Forskning har även visat att storytelling kan minska stress hos barn (Ku et al., 2025) och att informationsmaterial anpassat till familjer kan bidra till barns välmående (Zhao et al., 2024). Dessa faktorer kan kopplas till trygghet, och med detta i åtanke har gestaltningen utformats med fokus på begriplighet, igenkänning och stöd för samtal.

Arbetet har vissa begränsningar. Utprovningarna genomfördes på ett mindre antal deltagare och testerna gjordes tillsammans med vuxna och inte direkt med barn i den tänkta målgruppen. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom vuxna och barn sannolikt tolkar både språk och visuella uttryck på olika sätt, vilket gör att resultaten främst speglar vuxnas perspektiv. Utprovningar med barn hade därför kunnat ge en mer nyanserad bild av hur materialet uppfattas av målgruppen. Samtidigt hade sådana tester krävt fler etiska överväganden och anpassningar, eftersom arbetet behandlar ett känslomässigt svårt ämne och riktar sig till yngre barn. Däremot har testerna indikerat att materialet skulle kunna fungera som ett stöd för vuxna i samtal med barn i målgruppen, vilket var en central del av syftet.

Sammantaget visar resultatet att informationsdesign kan användas för att göra komplex medicinsk information mer tillgänglig för barn genom samspelet mellan text, bild och struktur. Kombinationen av berättande text och faktabaserad information visade sig fungera väl i gestaltningen. Berättelsen skapade identifikation och igenkänning, medan faktarutorna hjälpte till att konkretisera och förtydliga informationen. Genom att dela upp innehållet mellan narrativa och informativa delar blev materialet mer överskådligt samtidigt som det behöll ett tryggt och personligt tilltal.

Framtida forskning skulle kunna undersöka hur materialet upplevs direkt av barn i målgruppen, samt hur det skulle kunna vidareutvecklas med fler uppslag eller fler cancerformer. Det hade även varit intressant att undersöka hur materialet skulle kunna utformas för att användas digitalt, med exempelvis interaktiva element eller ljudstöd.

8.2 Slutsats

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur information om cancer kan gestaltas för barn i åldern 6–9 år på ett sätt som gör informationen begriplig och trygghetsskapande.

Resultatet visar att samspelet mellan narrativa, visuella och faktabaserade element är centralt för att göra informationen tillgänglig för målgruppen. Särskilt tydligt är att narrativet skapar emotionell tillgänglighet, medan faktadelarna bidrar till att förtydliga och konkretisera innehållet.

Gestaltningsförslaget utformades som ett informationsmaterial i bilderboksformat där berättande text kombineras med faktarutor och illustrationer. Genom att använda ett lugnt visuellt uttryck, ett konkret och enkelt språk och ett narrativ ur barnets perspektiv skapades ett material som syftar till att minska rädsla och öka förståelsen för både sjukdomen och behandlingen.

När det gäller den första underfrågan, vilka visuella och narrativa strategier som kan göra information begriplig för barn, visar arbetet att ikoniska illustrationer av igenkännbara situationer, i kombination med ett narrativ ur barnets perspektiv är effektiva strategier. Bilderna skapar igenkänning, medan berättelsen ger ett emotionellt sammanhang som gör informationen lättare att ta in.

Den andra underfrågan, hur ett material kan fungera både för barnet och som stöd i samtal med vuxna, besvarades genom bilderboksformatets dubbla orientering. Utprovningarna bekräftar att gestaltningen upplevdes fungera som ett stöd i samtal mellan vuxna och barn.

Sammantaget visar arbetet att information om cancer kan göras mer begriplig för barn genom att kombinera berättelser ur barnets perspektiv med konkreta illustrationer och åldersanpassade förklaringar. Kombinationen bidrar till att göra abstrakta medicinska processer mer begripliga och skapar samtidigt ett underlag för samtal mellan barn och vuxna.

9 Källförteckning

9.1 Tryckta källor

Abbott, H.P. (2021). *The Cambridge introduction to narrative*. (Third edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Bateman, J.A. (2014). *Text and image: a critical introduction to the visual-verbal divide*. London: Routledge.

Chandler, D. (2022). *Semiotics: the basics*. (Fourth edition.) London: Routledge.

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Y. (2017). *Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text*. (Andra upplagan). [Lund]: Studentlitteratur.

Furustig, H., & Sjöstedt, G. (2000). *Strategisk omvärldsanalys*. Studentlitteratur.

Hagvall Einarsrud, A. (2022). *En dum knöl i mammas bröst* (Första upplagan). Idus förlag.

Hellmark, C. (2004). *Typografisk handbok* (5. uppl.). Ordfront.

Kress, G.R. & Van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: the grammar of visual design*. (2. ed.) London: Routledge.

Lindqvist, J. (2016). *Klassisk retorik för vår tid*. (2., rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ledin, P. & Machin, D. (2018[2018]). *Doing visual analysis: from theory to practice*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Paananen, M. (2015). *När mormor fick cancer - en bok om livet* (Första upplagan). Idus förlag.

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod*. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

9.2 Elektroniska källor

Alfieri, S., Scacciati, B., Nardone, Z., Romeo, M., Andreescu, L., Chiorazzi, M., Dimastromatteo, P., Burattini, E., Berardi, R., Zappata, S., Belbusti, V., Gangeri, L. & Borreani, C. (2026). Communicating cancer to children: Strategies and needs of parents with cancer. A qualitative study. *Palliative and Supportive Care, 24*, (23), 1–18. https://doi.org/10.1017/S1478951525101272

Anhörigas riksförbund. (2021). *Boktips*. https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/Bok-och-filmtips-v2.pdf

Bröstcancerförbundet. (19 februari 2025). *Cytostatikabehandling (kemoterapi)* https://brostcancerforbundet.se/ombrostcancer/behandling/kemoterapicytostatikabehandling/

Bröstcancerförbundet. (24 mars 2026) *Olika stadier av bröstcancer*. https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/diagnostik/olika-stadier-av-brostcancer/

1177. (16 januari 2026). *Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk*. https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/att-ma-daligt-som-foralder/att-prata-med-barn-nar-en-foralder-ar-allvarligt-sjuk/#section-46471 (Hämtad 2026-04-10)

1177. (2 december 2025). *Bröstcancer*. https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/cancer/cancerformer/brostcancer/

1177. (17 februari 2023). *Vanliga frågor om cancer*. https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/cancer/fakta-om-cancer/vanliga-fragor-om-cancer/

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Jag vill veta. (u.å.) *Om Jag vill veta*. https://www.jagvillveta.se/om-jag-vill-veta/

Kenny, M., Duffy, K., Hilliard, C., O'Rourke, M., Fortune, G., Smith, O., Hynes, G. & Higgins, A. (2021). 'It can be difficult to find the right words': Parents' needs when breaking news and communicating to children with cancer and their siblings. *Journal of psychosocial oncology, 39,* (4), 571-585. https://doi.org/10.1080/07347332.2021.1890305

Ku, S. H., Chua, J. S., & Shorey, S. (2025). Effect of storytelling on anxiety and fear in children during hospitalization: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pediatric Nursing, 80,* (Januari-Februari), 41–48. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.11.006

Lilla krisinformation. (13 mars 2024). *Guide för vuxna: Skriv för barn*. https://lilla.krisinformation.se/globalassets/lilla-krisinfo/informationsmaterial/att-skriva-for-barn-v02-2024.pdf

Lilla krisinformation. (19 september 2025). *Om lilla krisinfo*. https://lilla.krisinformation.se/menyer/om-lilla-krisinfo/

Lilla Rädda Barnen. (u.å.). https://lilla.raddabarnen.se/

Martin, Bella., & Hanington, B. M. (2012). *Universal methods of design : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions*. Rockport Publishers.

Mina rättigheter. (u.å.). *6–9 år* https://minarattigheter.se/barn-och-unga-6-9ar/

Rakower, J., & Hallyburton, A. (2022). Disease Information Through Comics: A Graphic Option for Health Education. *Journal of Medical Humanities, 43,* 475–492. https://doi.org/10.1007/s10912-022-09730-9

Region Jönköpings län. (2025, april). *Att läsa om sjukdomar – för barn och unga*.

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/cfac408a-1467-4b50-95a9-d05fd34cd969

Sarı Uğurlu, B., & Apaydın, S. (2023). Content Analysis of Portrayals of Climate Change in Turkish Picturebooks. *Early Childhood Education Journal*, *52*, 1587–1600. https://doi.org/10.1007/s10643-023-01573-w

Sjukhusbiblioteken i Värmland. (2020). *Barn som anhöriga: Lästips från sjukhusbiblioteket*. https://regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a3256aa/1625701747202/Barn%20som%20anh%C3%B6riga%202020.pdf

Wallberg, B. (2019). *Cytostatikabehandling* (Reviderad 12:e upplaga). Cancerfonden. https://static-files.cancerfonden.se/Cytostatika.pdf

Xu, J., Huang, X, Zhang, J., Zhang, X., Yang, Y. & Xie, M. (2024). How Do Parents With Advanced Cancer Communicate With Their Children? A Systematic Review and Meta-Synthesis of Qualitative Studies. *Psycho-Oncology, 33,* (11), 1-19. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1002/pon.70018

Yamaji, N., Suzuki, D., Suto, M., Sasayama, K. & Ota, E. (2022). Communication Tools Used in Cancer Communication with Children: A Scoping Review. *Cancers, 14,* (19). https://doi.org/10.3390/cancers14194624

Zhao, S., Xiao, J., Liu, J., Tao, H., Liu, H., Chen, J., Bai, Y., Ding, J., Tang, S. & Huang, H. (2024). Interventions to improve illness-related communication between cancer patients and their minor children: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies. 160,* https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104910

Åkerman, J. & Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed 2024*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

9.3 Otryckta källor

Intervju 1, 9 april 2026, transkription. I författarens ägo.
Intervju 2, 14 april 2026, transkription. I författarens ägo.
Intervju 3, 15 april 2026, transkription. I författarens ägo.
Intervju 4, 15 april 2026, transkription. I författarens ägo.
Utprovning 1, 10 maj 2026, transkription. I författarens ägo.
Utprovning 2, 11 maj 2026, transkription. I författarens ägo.
Utprovning 3, 11 maj 2026, transkription. I författarens ägo.

9.4 Bildförteckning

Figur 1 Uppslag från boken När mormor fick cancer av Minna Paananen. Illustratör: Elisabeth Widmark 13
Figur 2 Sida från boken En dum knöl i mammas bröst av Annie Hagvall Einarsrud. Illustratör: Hanna Ingvarsson 13
Figur 3 Tabell över teman från intervjuresultat..... 16
Figur 4 Visualisering av designprocessen. Källa: Wikberg Nilsson et al (2021, s.31) 18
Figur 5 Sidplan över innehållets planerade struktur. Upphovsperson: Tina Håkansson 19
Figur 6 Mer detaljerade skisser av enskilda uppslag. Upphovsperson: Tina Håkansson 20
Figur 7 Skissutveckling av visualisering av cancerns olika stadier. Upphovsperson: Tina Håkansson 20
Figur 8 Första prototypen av uppslag 1. Upphovsperson: Tina Håkansson 21
Figur 9 Första prototypen av uppslag 2. Upphovsperson: Tina Håkansson 21
Figur 10 Gestaltningsförslag uppslag 1. Upphovsperson: Tina Håkansson..... 28
Figur 11 Gestaltningsförslag uppslag 2. Upphovsperson: Tina Håkansson..... 29

10 Bilagor

10.1 Analysmall

- Struktur och innehåll
  - Karaktärer, finns det någon barnet kan relatera till?
  - Vilken kontext?
  - Hur presenteras sjukdomen?
- Språk
  - Lugnt, dramatiskt?
  - Vilket tilltal används?
  - Förklaras svåra ord?
  - Använder man metaforer?
- Visuell kommunikation
  - Vad visas i bilderna?
  - Relation mellan bild och text
  - Bidrar bilderna till att förklara det som är svårt i texten?
- Informationsinnehåll
  - Hur mycket information?
  - Hur detaljerad eller förenklad är informationen?
  - Är informationen faktabaserad vs berättande?
- Trygghet och rädsla
  - Skapas trygghet?
  - Hur hanteras oro och rädsla?
  - Finns stöd och närvaro från vuxna?
- Målgruppsanpassning
  - Passar det för 6–9 år?
- Är mängden information rimlig för åldern?

10.2 Samtyckesformulär

Samtycke till deltagande i studie

Ansvarig
Tina Håkansson
Informationsdesign Visualisering och textdesign
Mälardalens universitet
E-post: thn23005@student.mdu.se

Medgivande
Jag har tagit del av information om studien och är medveten om att deltagandet är frivilligt.
Jag samtycker till att delta i en intervju inom ramen för ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktning visualisering och textdesign vid Mälardalens universitet. Studien handlar om hur information om cancer kan utformas för att vara begriplig och trygghetsskapande för barn i åldern 6–9 år.

Jag är informerad om att:

- Mina svar kommer att behandlas anonymt, inga personuppgifter kommer att redovisas
- Materialet endast kommer att användas i studiesyfte
- Jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange någon anledning
- Om jag väljer att avbryta kommer de uppgifter jag lämnar inte att användas
- Inspelat material raderas efter att arbetet är slutfört

☐ Jag samtycker till att intervjun spelas in

Namn: _____
Datum: _____

10.3 Intervjuguide

Bakgrund:

- Ålder på barnet?
- Läser barnet själv?

Erfarenhet:

- Har ni pratat om cancer eller andra allvarliga sjukdomar hemma?
- Har ditt barn haft några frågor om sjukdom?

Svårigheter:

- Vad tycker du är svårt med att förklara allvarlig sjukdom för ett barn?

Behov:

- Finns det något du hade velat ha hjälp med i sådana samtal?

Material:

- Har du sett något material om sjukdom som riktar sig till barn? (böcker, broschyrer, webb osv)
- Har du själv använt dig av något sådant material?
- Om ja, vad fungerade bra/mindre bra? Varför?
- Föredrar du något att läsa tillsammans med barnet eller något som barnet kan ta del av själv?

Utformning:

- Hur tycker du att information till barn bör vara utformad för att vara lätt att förstå?
- Vad tycker du är viktigt för att informationen ska kännas trygg och inte skrämmande?
- Är det något mer du tycker är viktigt att tänka på när man informerar barn om svåra saker?

10.4 Intervjuguide författarintervju

Bakgrund

- Vill du berätta lite om bakgrunden till boken och varför du valde att skriva den?

Syfte

- Vad var viktigast för dig att barnet skulle förstå efter att ha läst boken?

Att förklara sjukdomen

- Hur tänkte du kring hur konkret du skulle vara när du förklarade cancer?
- Hur resonerade du kring vilka begrepp som behövde förklaras och inte?
- Var det något som var särskilt svårt att förklara?

Urval och avgränsning

- Hur valde du vad som skulle vara med i berättelsen?
- Finns det något du aktivt valde att inte ta med?

Trygghet

- Hur tänkte du kring balansen mellan att ta med information men samtidigt inte skapa oro?
- Vad tror du är viktigt för att barn ska känna sig trygga när de läser?

- Om du skulle ta fram ett mer renodlat informationsmaterial för barn idag, vad tycker du är det viktigaste att tänka på?

10.5 Frågeguide utprovning

- Vad är ditt första intryck av uppslaget?
- Hur upplever du samspelet mellan berättelsen och faktadelarna?
- Är det något som känns oklart eller svårt att förstå?
- Hur upplever du mängden text?
- Är det något i texten som är för svårt eller för lätt?
- Hur upplever du illustrationerna?
- Hur upplever du att materialet hade fungerat för barn i målgruppen?
- Hur tror du att materialet skulle fungera som stöd i samtal med barn om sjukdom?
- Är det något du hade velat förändra eller lägga till?

10.6 Slutgiltigt gestaltningsförslag

En morgon kommer mamma och sätter sig bredvid mig i soffan.
Hon ser lite allvarlig ut.

”Jag har något att berätta”, säger hon.
”Jag har varit hos doktorn. Jag har hittat en knöl i mitt bröst, och doktorn säger att jag har fått något som heter bröstcancer”.



Vad är cancer?

Din kropp består av miljarder små celler som delar sig så att kroppen kan fungera. Ibland blir det fel när en cell delar sig. Då kan celler bildas som inte slutar dela sig när dom ska. Då bildas en klump som kallas tumör.

När tumören sitter i ett bröst kallas den bröstcancer.



Frisk cell



Cancercell



1 Cancern sitter i bröstet och har precis börjat växa. Den kan ibland vara så liten att den inte märks.



2 Cancern är lite större och kan ha börjat sprida sig till små körtlar i närheten av bröstet, till exempel i armhålan.



3 Cancern är större i bröstet eller har spridit sig till fler körtlar i kroppen.



4 Cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Då kan man behöva mer behandling.

En dag fick jag följa med mamma till sjukhuset. Hon skulle få en medicin som kallas cellgift som ska hjälpa henne att bli frisk.

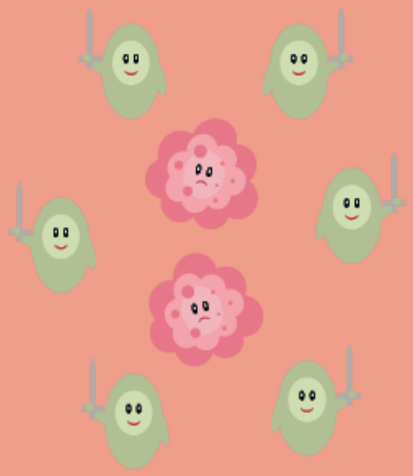
Mamma fick en tunn slang i armen som var kopplad till en påse med medicin. Det är en stark medicin som ska försöka döda cancercellerna.



Hur fungerar cellgift?

Cellgifter är en stark medicin som åker runt i blodet och söker upp cancercellerna för att döda dom så att dom slutar växa och dela sig.

Tyvärr kan cellgifterna inte alltid skilja på cancer-celler och friska celler, så kroppen behöver vila mellan behandlingarna. Då hinner dom friska cellerna bli starka igen.



Hur mår man av behandlingen?

När cellgifterna har svårt att skilja på cancerceller och friska celler kan man känna sig sjuk.

Den som får behandling kan må illa och ha svårt att äta. Man kan också bli väldigt trött och inte orka vara med på allt man egentligen vill göra.
Vissa cellgifter kan göra så att man tappar sitt hår, men det växer tillbaka när behandlingen är klar.